

Fecha Última Actualización: 27-05-2022 12:23:56

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Juan Segundo Antonio Ponce Silva
Edad : 57a 6m 0d
Dirección : Caremapu 1893

Rut : 9.868.557-K
Fecha Nacto: 27/11/1964
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2209272
Sexo : Masculino
Teléfono : 950514653

N° Epicrisis
307909

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Neurología / Neurocirugía

Fecha Ingreso : 11/05/2022 11:06

Días Estadía: 16

Unidad de Egreso : Neurología / Neurocirugía

Fecha Egreso : 27/05/2022 12:05

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

CIRUGIA ELECTIVA DE TUMOR DE FOSA POSTERIOR

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: JuanSegundo Ponce Silva
Edad: 57 años
Run 9868557-k
Fecha de nac 27/11/1964

ANTECEDENTES

- Médicos: HTA, DM2NIR
- Quirgicos: manguito rotador (2019)
- Fármacos (-)
- Alergias (-)
- Hábitos: TAbaco (+); OH (+); Drogas (-)

HISTORIA ACTUAL

Paciente con historia de cefalea de meses de evolucion, de intensidad progresiva, que se asocia a trastorno de la marcha y visión borrosa. Se realiza estudio de forma ambulatoria con resonancia de encefalo donde evidencia lesion tumoral de fosa posterior. Ingresa el 11/05 para resolucion quirurgica.Durante hospitalización con indicacion de corticoides endovenosos y sin deterioro neurologico.

Paciente ingresa a pabellon el 18/05/22 AM; Cursa inestable durante pabellón. Realiza 3 episodios de PCR; ocupando 10 ampollas de adrenalina en total y transfundiendo 6 U GR + 6 U plasma + 6 U plaquetas con un estimado de 6 lt de pérdida. Ingresa a UPC inestable, con adrenalina + noradrenalina.

EXAMENES DE LABORATORIO

17/05: hcto 51.4%, Hb 17.3, GB 11.930, plaq 272.000
11/05: PCR COVID negativo

IMAGENES DE INGRESO

RM encefalo (01/03/22): sin informe. Impresiona lesión en fosa posterior de aprox 4.5 x 4.5 x 3.1cm

TAC TAP (11/05/22): Examen sin evidencias de una lesión primaria en este estudio realizado sin contraste. Diverticulosis

Fecha Epicrisis : 27/05/2022 12:23

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 27-05-2022 12:23:56

Página 2 de 3

colónica sin signos de diverticulitis. Leve ateromatosis cálcica de la aorta abdominal.

DIAGNOSTICO DE INGRESO

1. Lesion tumoral fosa posterior
Obs meningioma vs metastasis
2. Antecedentes

EVOLUCION DURANTE HOSPITALIZACION

Hemodinamia: Cursa inestable durante pabellón. Realiza 3 episodios de Paro Cardio Respiratorio; se ocupan 10 ampollas de adrenalina en total y transfundiéndose 6 U GR + 6 U plasma + 6 U plaquetas con un estimado de 6 lt de pérdida. Ingres a UCI el 18/05 en horas de la tarde, inestable, con adrenalina + noradrenalina (adrenalina suspendida a su ingreso a UCI). Eco bedside muestra corazon bradicardico pero con buena contractilidad. Requirio 1 mg de atropina por bradicardia hasta 37. Se mantuvo con levophed (hasta 0.07) para PAM > 65 mmHg + dobutamina (hasta 5 mcg/kg/min). Paciente logra suspender DVA el dia 20/05 en horas AM. Al momento con FC peri 70, macrohemodinamia y microhemodinamia autosostenida. Estable se mantiene en sala. Sin alteraciones hemodinamicas

Ventilatorio: Ingres a UCI con IOT, prueba de ventilacion espontanea bien tolerada, logrando suspender sedacion, y logra weaning exitoso el 19/05 aproximadamente a las 11:00 am. Paciente al momento estable, con bajo requerimientos de oxigeno por naricera, con sat O2 >92%. Cursando TRALI post politransfusion, estable. Extubandose sin dificultad. En sala evolucionando favorablemente sin necesidad de apoyo.

Neurologico: Con exéresis tumoral fosa posterior (18/05). TAC cerebral control post operatorio: adecuada resección tumoral. Cambios post quirurgicos fosa posterior. No evidencia de complicación hemorrágica a nivel de sitio quirúrgico. Paciente con medidas de neuroproteccion y dexametasona para control de edema tumoral. En descenso, control con TC en sala, cambios post quirurgicos. Herida seca

DIAGNOSTICOS DE EGRESO

1. POP Lesion tumoral fosa posterior (FI 18/05; 08:54)
- Obs meningioma vs metastasis
2. PCR recuperado intra pabellón
- Shock hipovolemico resuelto
3. TRALI
- Politrasnfundido
2. Antecedentes

En base a buena evolucion clinica, se decide realizar alta médica.

Diagnóstico de Egreso

Tumor cerebral -
Paro cardiorespiratorio recuperado -
Shock hipovolemico -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Vigil, cooperador, GCS 15
NC: RFM+/, oculomotilidad conservada, sin PFC
Motor: M5 en 4 extremidades
Sensibilidad conservada

Plan Post Alta

Reposo relativo
Regimen liviano
Paracetamol 1gramo cada 8horas x 5 dias VO
Predinsona 20mg cada dia x 7 dias y suspender VO
Omeprazol 20mg cada dia x 7 dias VO

Fecha Epicrisis : 27/05/2022 12:23

Página 2 de 3

Fecha Última Actualización: 27-05-2022 12:23:56

Página 3 de 3

Control con Dr. Vladirmir Kraudy, en 3 semanas, en CDT pasillo 9 (pedir sobrecupo)

Lavado de cabello en 5 días post alta. Con shampoo, ph neutro, ducha corta. Secado con secador de pelo tibio frío.

Control medico SOS

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Liviano

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Pedro Ignacio Labbe Cavieres

Becado/Residente

Médico Tratante (Staff)